MÓDULO 7 · INVESTIGACIÓN CLÍNICA, RWE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIA

Evidencia del mundo real

Si en el módulo anterior la RWE se abordó como categoría de evidencia, aquí el foco es distinto: cómo se integra la RWE dentro de la estrategia médica de un producto, y qué papel juega el MSL en esa integración. La RWE ha dejado de ser un complemento opcional para convertirse en un componente central de los planes integrados de generación de evidencia (Integrated Evidence Generation Plans, IEGP) que muchas compañías farmacéuticas utilizan hoy para coordinar toda su actividad de investigación alrededor de un producto.

- Aquí el foco es cómo la RWE se integra en la estrategia médica del producto
- Es ahora componente central de los planes integrados de evidencia (IEGP)
- Ha dejado de ser un complemento opcional

Un IEGP bien construido combina, de forma coordinada y no aislada, varios elementos: estudios de Fase IIIb y IV, colaboraciones de investigación iniciada por el investigador, marcos de recogida de datos del mundo real, capacidades de registro, y estudios de resultados en salud y economía de la salud (HEOR). El objetivo de integrar todos estos elementos en un único plan es evitar la generación de evidencia dispersa y reactiva, y en su lugar construir de forma deliberada el cuerpo de evidencia que el producto necesitará a lo largo de su ciclo de vida: para sustentar decisiones de acceso y reembolso, para responder a las preguntas más frecuentes de los HCP, y para mantener la relevancia científica del producto años después de su aprobación inicial.

Plan integrado de evidencia (IEGP)

→ **Estudios Fase IIIb/IV**
→ **Estudios iniciados por el investigador**
→ **Datos del mundo real**
→ **Registros**
→ **Estudios HEOR**

El papel del MSL en esta estrategia es el de fuente primaria de inteligencia científica del terreno. Los insights que un MSL recoge en sus interacciones con KOLs y clínicos — qué preguntas quedan sin responder, qué subgrupos de pacientes generan más incertidumbre clínica, qué comparadores le interesan realmente a la comunidad médica— son, según la literatura especializada en planificación de evidencia, un insumo directo para priorizar qué preguntas de investigación aborda el plan de evidencia, para refinar el diseño de futuros protocolos, y para dar forma a las estrategias de RWE y HEOR más alineadas con las necesidades reales de acceso y reembolso.

EL MSL COMO FUENTE DE INTELIGENCIA DEL TERRENO

- Insights de interacciones con KOLs y clínicos sobre preguntas sin responder
- Insumo directo para priorizar qué preguntas aborda el plan de evidencia
- Ayuda a dar forma a las estrategias de RWE y HEOR alineadas con acceso y reembolso

Esto convierte al MSL en un actor bidireccional: no solo comunica la evidencia generada por la compañía hacia fuera, sino que canaliza hacia dentro las necesidades de evidencia identificadas en el terreno, alimentando directamente el ciclo de planificación estratégica. Esta función de "traducción" entre lo que el mercado científico necesita saber y lo que la organización puede investigar es, según los marcos de Medical Affairs más recientes, uno de los valores diferenciales más importantes de la función MSL dentro de la organización médica.

- El MSL es un actor bidireccional: comunica hacia fuera y canaliza necesidades hacia dentro
- Una función de "traducción" entre lo que el mercado necesita y lo que la organización investiga
- Uno de los valores diferenciales más importantes de la función MSL

Para que esta contribución sea efectiva, el MSL necesita procesos estructurados de captura y comunicación de insights (tratados en el módulo de Insights) y una relación de confianza con los equipos internos de evidencia, HEOR y acceso al mercado, de forma que la información fluya en ambas direcciones de manera sistemática y no anecdótica.

- Requiere procesos estructurados de captura y comunicación de insights
- Y una relación de confianza con los equipos de evidencia, HEOR y acceso al mercado
- Para que la información fluya en ambas direcciones de forma sistemática